Nevrologiya

Kvanil

Sitikolin

Tabletka 500 mg; in'eksiya 500 mg/4 ml va 1000 mg/4 ml

Nootrop, neyroprotektor (N06BX06)



QISQACHA · 500–2000 mg/sut. O'tkir bosh suyagi ichi qon quyilishida maks. 1000 mg/sut.

Ko'rsatmalar

- Insultning o'tkir bosqichi, asoratlari va oqibatlari
- Bosh miya jarohati va uning nevrologik oqibatlari
- Degenerativ va tomir serebral patologiyasida kognitiv, sensor, motor va xulq buzilishlari

Dozalash

- Tabletka: 500–2000 mg/sut (1–4 tab)
- In'eksiya: 500–2000 mg/sut v/i yoki m/i; v/i sekin 3–5 daqiqa yoki tomchilab 40–60 tomchi/daq
- O'tkir bosh suyagi ichi qon quyilishida 1000 mg/sutdan oshmasin (30 tomchi/daq)
- Keksalarga tuzatish shart emas; keyin peroral shaklga o'tish mumkin

Mumkin emas

O'ta sezuvchanlik; parasimpatik nerv tizimi tonusi yuqoriligi

Nojo'ya ta'sirlar

Juda kam (<1/10 000): bosh og'riq, uyqusizlik, qo'zg'aluvchanlik, AQB o'zgarishi, ko'ngil aynishi, toshma

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Neyroprotektor va apoptoz ingibitori: o'tkir davrda ham, reabilitatsiyada ham samarali — sxemani keskin o'zgartirish shart emas
- Yuqori dozada ham xavfsizligi platseboga yaqin
- Substansiya Yaponiyada ishlab chiqarilgan; narxi qulay

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Kvanil — neyroproteksiya va tiklanish!»

- Ishemik insultning dastlabki 24 soatida peroral sitikolin 3 oy ichida to'liq tiklanish ehtimolini oshiradi
- O'tkir davrda ham, reabilitatsiyada ham samarali — sxemani o'zgartirish shart emas
- In'eksiya va tabletka — bosqichli davo; substansiya Yaponiyada

O'zingizni tekshiring

Kvanil levodopa bilan qanday ta'sirlashadi?
Levodopa ta'sirini kuchaytiradi; meklofenoksat bilan birga berilmaydi.

O'tkir bosh suyagi ichi qon quyilishida Kvanilning maksimal dozasi?
1000 mg/sut, tomchilab 30 tomchi/daqiqa.